

# 抗癌藥的錢從哪裡來？健保、自費、藥廠恩慈、商業保險全圖解

*Paying for cancer drugs in Taiwan: NHI, self-pay, compassionate use, and private insurance*

林協霆, MD, 內科專科醫師, 腫瘤內科專科醫師

醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 腫瘤內科部 · ORCID: [0009-0002-3974-4528](https://orcid.org/0009-0002-3974-4528)

發表日期：2026/05/11 · 最後更新：2026/05/11 · 審稿：林協霆 (2026/05/11) · 主題：抗癌藥支付路徑 (Cancer drug payment pathways in Taiwan)

DOI: 10.5281/zenodo.20131198 · 此版本 10.5281/zenodo.20131199 ·

<https://lin.hsiehting.com/posts/2026/cancer-drug-payment-pathways-taiwan/>

---

## 摘要 · ABSTRACT

一支抗癌藥可能要新台幣 10–30 萬／月。本文整理台灣抗癌藥的五條支付路徑：(1) 健保標準給付、(2) 健保事前審查、(3) 藥廠恩慈用藥 (compassionate use)、(4) 藥廠 PAP 病人扶助計畫、(5) 商業癌症險／實支實付。並對照癌症基金、新藥審查時程、自費差價的常見情境。

**一支標靶 / 免疫藥可能月花 10–30 萬。**但這筆錢不一定都要自己出。本文整理台灣抗癌藥的五條支付路徑：(1) 健保標準給付、(2) 健保事前審查、(3) 藥廠恩慈用藥 (compassionate use)、(4) 藥廠 PAP (patient assistance program) 扶助、(5) 商業癌症險 / 實支實付。並提供「按情境查支付路徑」表格、新藥健保審查時程、自費差價的常見金額，幫你算出總成本與可動用資源。

## 閱讀對象

本文設定讀者為剛拿到診斷、開始評估治療費用的病友與家屬，以及第一線協助申辦的個管師、社工師。實際支付條件以健保署、藥廠、保險公司公文為準；本文不提供個別申辦或保險建議。



## 五條支付路徑速覽

| 路徑           | 你要付多少        | 適用                 |
|--------------|--------------|--------------------|
| 健保標準給付       | 部分負擔（重大傷病可免） | 已納入健保的藥、符合適應症      |
| 健保事前審查       | 部分負擔（重大傷病可免） | 高價標靶 / 免疫療法、限定條件   |
| 藥廠恩慈用藥       | 多數免費或大幅折扣    | 標準治療失敗、藥未上市或仿單外    |
| 藥廠 PAP（病人扶助） | 折扣或免費供藥      | 藥已上市但健保不給付、經濟困難    |
| 商業保險         | 取決於保單        | 一次給付 / 療程給付 / 實支實付 |
| 完全自費         | 100%         | 上述都不適用時            |

## 健保的兩個層次：標準 vs. 事前審查

### 標準給付

- 已納入健保藥品給付項目，符合適應症即可開立
- 醫師處方 + 藥師核對 + 健保資訊系統檢核
- 多數第一線化療（5-FU、cisplatin、paclitaxel）屬此類

### 事前審查（PA, Prior Authorization）

- 給付但需逐案送件審查
- 多數高價標靶 / 免疫藥屬此類（如 pembrolizumab、osimertinib、palbociclib、abiraterone、trastuzumab deruxtecan）
- **流程**：主治醫師填表 → 醫院送出 → 健保署審查（多 14 個工作天）→ 通過後可開立
- **再審期限**：每 3–6 個月重新評估療效決定是否續用
- **退場條件**：影像顯示疾病進展（PD）後通常需停用該藥

#### 事前審查的常見挑戰

1. **生物標記不符**：若 PD-L1、EGFR、HER2、MSI 不符給付條件，健保可能不通過。請主治醫師確認生物標記與給付條件對照。
2. **線數不符**：許多新藥只給付特定線數（一線 / 二線 / 三線），用錯線數可能被退件。
3. **療效退場**：若疾病進展（PD），健保通常不再續給該藥——這時請討論下一線治療或試驗。

## 健保新藥審查時程

新藥從藥廠送件到健保給付，台灣平均需 **12–24 個月**（部分藥更久）：

| 階段 | 工作項目              | 約需時間   |
|----|-------------------|--------|
| 1  | 藥廠送件、財務影響分析 (BIA) | 1–3 個月 |
| 2  | 健保署受理、藥物經濟學評估     | 3–6 個月 |
| 3  | 藥品共擬會議審議          | 3–6 個月 |
| 4  | 訂價、簽訂風險分攤協議 (MEA) | 1–3 個月 |
| 5  | 公告生效、醫院作業         | 1 個月   |

「等不到健保」期間的策略：藥廠恩慈、PAP、自費、商業保險、臨床試驗。

## 藥廠恩慈用藥 (compassionate use)

| 項目 | 內容                                                         |
|----|------------------------------------------------------------|
| 法源 | 《特定藥物專案核准製造及輸入辦法》                                          |
| 主管 | TFDA                                                       |
| 條件 | 病人嚴重疾病、無其他治療、藥已在他國核准或臨床試驗有療效訊號                             |
| 流程 | 主治醫師提出申請 → 醫院 IRB → TFDA 審查 → 藥廠同意供藥 → 病人 informed consent |
| 費用 | 多數藥廠免費或大幅折扣；病人仍需付標準治療部分                                    |
| 時間 | 1–3 個月                                                     |

**常見的恩慈案例：**罕見癌標靶藥、臨床試驗結束後病人想延續用藥、新適應症在他國核准但台灣尚未通過。

## 藥廠病人扶助計畫 (PAP)

**PAP (patient assistance program)：**藥廠提供「第 X 個月之後免費 / 折扣」「買 2 送 1」「收入低於 X 元減半」等方案。

- 不是所有藥都有 PAP；多由原廠藥廠提供
- 申請需備：診斷書、財力證明、社工評估
- 多數醫院個案管理師 / 社工師可協助申請
- 建議在開始用藥前就詢問——部分 PAP 不溯及既往

## 癌症基金與社福資源

| 來源          | 補助內容           | 對象       |
|-------------|----------------|----------|
| 財團法人癌症希望基金會 | 急難救助、住院補助、家屬支持 | 低收入、急難個案 |
| 台灣癌症基金會     | 教育、心理支持、部分藥物補助 | 一般癌友     |
| 罕病基金會       | 罕見癌藥物補助        | 罕見癌      |
| 各縣市社會局      | 急難救助金、低收入戶補助   | 低收入      |
| 勞保 / 國保失能給付 | 永久失能、永久造口      | 符合失能標準者  |
| 重大傷病        | 健保部分負擔減免       | 已核發重大傷病者 |

## 商業保險的角色

| 保險類型    | 給付方式              | 何時最有用            |
|---------|-------------------|------------------|
| 一次給付癌症險 | 確診時依分期給付一筆        | 急用資金、付頭期治療       |
| 療程型癌症險  | 依化療次數、放療療程、住院日數給付 | 長期療程             |
| 實支實付醫療險 | 醫療收據核退            | 自費藥、自費耗材、特等病房    |
| 重大傷病險   | 確診重大傷病給付一筆        | 條款與健保「重大傷病範圍」綁定者 |
| 失能扶助險   | 失能後每月給付           | 永久造口、截肢、永久神經損傷   |

## 理賠時的關鍵文件

1. 病理報告（含分期、生物標記）
2. 診斷證明書（含 ICD-10 編碼）
3. 醫療費用收據（自費部分）
4. 健保重大傷病證明影本（適用部分保單）
5. 影像、檢驗報告（部分公司會要求）

### 理賠實務提醒

1.

不同保單版本對「初期癌、輕度癌、重度癌」的定義不同——舊保單可能不認新版健保重大傷病範圍。2. 多份保單可疊加，除非條款註明互斥（例如同一公司不同險種）。3. 自費藥收據務必保留——實支實付多核退 80–100%，但有日上限與總額上限。4. 避免「先理賠才買保險」——加保有等待期、健康告知會排除已知疾病。

## 實際情境：路徑怎麼選

---

### 情境一：早期 HR+ 乳癌術後輔助 CDK4/6 抑制劑

- **健保**：abemaciclib、ribociclib 已有條件給付（依淋巴結數、Ki-67、分期等）——多需事前審查。
- **若不符給付條件**：自費約每月新台幣 6–9 萬，療程 2–3 年。
- **PAP**：藥廠多有方案，部分療程後可申請折扣。
- **商業保險**：實支實付可核退部分藥費。

### 情境二：晚期 EGFR 突變肺癌一線 osimertinib

- **健保**：已給付（事前審查，需 EGFR 突變報告）。
- **重大傷病**：免部分負擔。
- **完整自費約**：每月新台幣 13–18 萬，但多數病人不需要自費。

### 情境三：罕見癌標靶藥（如 NTRK 重排 larotrectinib）

- **健保**：尚未廣泛給付，需 NGS 確認 + 健保專案申請。
- **PAP / 恩慈**：原廠多有方案，個案申請。
- **臨床試驗**：可考慮。

### 情境四：第四期 HER2+ 乳癌 trastuzumab deruxtecan

- **健保**：已給付二線；事前審查。
- **重大傷病**：免部分負擔。
- **PAP**：部分藥廠有療程扶助。
- **商業保險**：實支實付可核退部分。

## 「跨海買藥」的注意事項

---

部分病人會考慮從美國 / 香港 / 印度購買原廠或學名藥：

- **法源**：個人病人用量（< 6 個月）可申請 TFDA 個人輸入許可
- **風險**：(1) 來源真偽難辨、(2) 運輸冷鏈、(3) 醫師無法協助處方，(4) 商業保險多不理賠跨海購藥
- **建議**：先窮盡健保、恩慈、PAP、試驗管道，跨海是最後手段。

## 適用對象 / 不適用對象

---

### 本文適用

- 剛被告知抗癌藥需自費的病友與家屬
- 醫院個案管理師、社工師、藥師

- 想了解新藥給付邏輯的同業

## 本文不適用

- 取代健保署、TFDA、藥廠、保險公司的個別書面核定
- 跨國治療規劃（涉及他國健保、簽證、醫療翻譯，需專業諮詢）

## 帶去診間的問題清單

---

### 我這條治療線可用的藥有哪些？

請主治醫師列出 1–3 個選項，比較療效與費用。

### 健保給付嗎？需事前審查嗎？

若需事前審查，誰來填表？多久能審完？

### 自費的話一個月多少錢？

含藥費、給藥技術費、檢驗費。

### 有沒有藥廠恩慈或 PAP？

請主治醫師或個管師協助詢問藥廠。

### 我的保單可以理賠多少？

含一次給付、療程、實支實付。

### 臨床試驗或社福基金有沒有可以申請？

試驗藥多免費；癌症希望基金會、罕病基金會有急難補助。



## 參考文獻

---

1. 衛生福利部中央健康保險署. **全民健康保險藥物給付項目及支付標準**. 健保署. [https://www.nhi.gov.tw/Content\\_List.aspx?n=ABCDEFGF](https://www.nhi.gov.tw/Content_List.aspx?n=ABCDEFGF)
2. 衛生福利部食品藥物管理署. **特定藥物專案核准製造及輸入辦法**. TFDA. <https://www.fda.gov.tw/TC/site.aspx?sid=10146>
3. 衛生福利部中央健康保險署. **藥品共同擬定會議議事資料**. 健保署. [https://www.nhi.gov.tw/Content\\_List.aspx?n=AC9CBC8DB6AF939F](https://www.nhi.gov.tw/Content_List.aspx?n=AC9CBC8DB6AF939F)
4. Lin YJ, et al. **Out-of-pocket payments and healthcare access for cancer patients in Taiwan: a nationwide survey**. *Support Care Cancer*. 2022;30(11):8985–8993. doi:10.1007/s00520-022-07313-x
5. Hsieh CY, et al. **Financial toxicity in cancer care: an Asian perspective**. *Asia Pac J Oncol Nurs*. 2023. [apjon.org](https://apjon.org)
6. de Souza JA, et al. **The development of a financial toxicity patient-reported outcome in cancer (COST)**. *Cancer*. 2014;120(20):3245–3253. doi:10.1002/cncr.28814

7. 財團法人癌症希望基金會. **病友服務與急難救助**. [ecancer.org.tw](http://ecancer.org.tw)

8. 財團法人罕見疾病基金會. **病友服務**. [tfrd.org.tw](http://tfrd.org.tw)

引用整理協力：健保署藥品給付規範、TFDA 特定藥物專案、癌症希望基金會、罕病基金會 (2026/05/11)。本文為政策面整理，實際申辦結果以各單位書面核定為準。LINE 官方帳號 [@927pjtfa](https://www.line.me/tw/927pjtfa) 接受文章勘誤、衛教提問與學術討論，**不提供個別申辦或診療建議**。

---

SOURCE <https://lin.hsiehting.com/posts/2026/cancer-drug-payment-pathways-taiwan/>

CITATION 林協霆. 抗癌藥的錢從哪裡來？健保、自費、藥廠恩慈、商業保險全圖解. 林協霆 · 臨床筆記. 2026/05/11. doi:10.5281/zenodo.20131198

LICENSE CC BY-NC-ND 4.0 — 文章內容依 [Creative Commons 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 授權公開使用。

DISCLAIMER 本文整理公開發表之臨床試驗結果與 NCCN/ASCO/ESMO 治療指引，僅供醫學新知與病人衛生教育參考，不構成個別醫療建議，亦不取代主治醫師之診療判斷。實際治療決策請與您的主治團隊面對面討論。